## 四、终身左甲状腺素替代治疗

1.小剂量逐渐递增，缺血性心脏病起始剂量要小、调整剂量要慢

2.每 **4-6 周**测定 **TSH** 以调整 L-$T_4$ 剂量（但中枢性甲减要依据 $FT_4$ 而非 TSH 调整剂量）

小结 TSH：反应甲状腺功能最敏感，诊断亚临床甲亢和亚临床甲减，鉴别原发与继发性甲减，调整左甲状腺素剂量的 ttsx 关键

3.抢救黏液性水肿昏迷首选碘塞罗宁 **L-$T_3$**（作用快、持续短）

甲减危象

## 真题解析·甲状腺功能减退症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2019N88-90 A 男性，68 岁。5 个月来渐进性乏力，食欲下降，1 个月来嗜睡，活动后感心悸，气短，下肢水肿，便秘。无体重下降。既往无冠心病、糖尿病病史。查体：T 36℃，P 52 次/分，BP 100/85mmHg，神情淡漠，高枕位，颜面水肿，皮肤干燥，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音低，肝肋下 1.5cm，双下肢胫前非凹陷性水肿(+)，跟腱反射减弱。

心包积液导致循环回流障碍

心包积液　扩心病

心包液体会影响听诊

甲减合并心包积液

88.该患者最可能的诊断为 第一反应:甲减

A.甲状腺功能减退症

B.渗出性心包炎

心包积液的Beck三联征:心音遥远、颈静脉怒张、血压下降,脉压减小

C.慢性心力衰竭

D.慢性肾衰竭

89.对明确诊断最有价值的血液检查项目是

A.NT-pro BNP

B.$T_3$、$T_4$、TSH

C.Cr、BUN

D.$K^+$、$Na^+$、$Cl^-$

90.该患者应选择的治疗原则是

A.替代治疗

B.手术治疗

C.放射治疗

D.免疫抑制剂治疗

胺碘酮可导致T4型甲亢又可导致甲减

2. 2020N88-90 A 女性，68 岁。1 个月来乏力、畏寒、胸闷、气短、记忆力明显减退，食欲差，夜间愿高枕卧位。既往因心律失常服用胺碘酮治疗，有高脂血症、关节痛史。入院查体：T 35.9℃，P 84 次/分，BP 100/85mmHg，高枕位，表情淡漠，皮肤干燥，睑结膜稍苍白，颈静脉充盈，甲状腺不大，双肺(-)，心浊音界扩大，心律整，$S_1$ 遥远，肝脾触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(+)，跟腱反射迟钝。

扩心病　心包积液

88.该患者应首先考虑的疾病诊断是 甲减合并心包积液

A.甲状腺功能减退症

B.扩张型心肌病

甲状腺激素又促进脂类分解又促进脂类合成,以分解为主,甲减患者的血胆固醇↑→动脉粥样硬化

C.结核性心包炎

D.干燥综合征